

SYNDROMES GERIATRIQUES – HOPITAL DE LAVAUX

SYNDROMES GER	DEPISTAGE / SCORE	DETAILS DES TESTS																													
Troubles cognitifs	- Mini Cog = 3 mots + test de l’horloge - MMS / Test horloge - CAM	CAM = confusion assessment method 1. début soudain et fluctuation des symptômes 2. inattention : distraction, difficultés à focaliser son attention 3. désorganisation de la pensée : suite d’idées illogique, incohérence 4. troubles de la vigilance : alerte – vigile – léthargique – stuporeux - comateux																													
Dépression	- (mini)GDS	GDS 4 items 1) Vous sentez-vous souvent découragé.e et triste ? oui → 1 pt 2) Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? oui → 1 pt 3) Etes-vous heureux.se la plupart du temps ? non → 1 pt 4) Avez-vous l’impression que votre situation est désespérée ? oui → 1 pt Risque dépression si total >1point		GDS 15 items : - 0 - 5 points : probable absence de dépression - 5-10 points : probable dépression légère à modérée - 11-15 points: probable dépression grave																											
TME / Chutes	- Nombre de chutes durant les derniers 6 / 12 mois - Tinetti (équilibre) - CABYNET M (prévention primaire et secondaire des chutes et fractures) - Facteurs de risque de chute • intrinsèques • extrinsèques • situationnels	<table><tr><td>TINETTI</td><td>Equilibre</td><td>Risque chute</td><td>Score</td></tr><tr><td rowspan="4">Sans moyen auxiliaire</td><td>Stable</td><td>Faible</td><td>26-28</td></tr><tr><td>Légèrement instable</td><td>Modéré</td><td>22-25</td></tr><tr><td>Instable</td><td>Important</td><td>18-21</td></tr><tr><td>Très instable</td><td>Très important</td><td><18</td></tr><tr><td rowspan="3">Avec moyen auxiliaire</td><td>Stable</td><td>Modéré</td><td>22-23</td></tr><tr><td>Instable</td><td>Important</td><td><21</td></tr><tr><td>Très instable</td><td>Très important</td><td><18</td></tr></table> Chaussures Alarme Barrières architecturales Yeux Nutrition (calcium, vit D) Exercice Toxique (OH, médication, psychotropes) Moyens auxiliaires	TINETTI	Equilibre	Risque chute	Score	Sans moyen auxiliaire	Stable	Faible	26-28	Légèrement instable	Modéré	22-25	Instable	Important	18-21	Très instable	Très important	<18	Avec moyen auxiliaire	Stable	Modéré	22-23	Instable	Important	<21	Très instable	Très important	<18	Facteurs de risque - intrinsèques (baisse acuité visuelle, équilibre, troubles musculo-articulaires, troubles cognitifs, hypotension orthostatique) - extrinsèques (polymédication, barrières architecturales) - situationnels (activité à risque)	
TINETTI	Equilibre	Risque chute	Score																												
Sans moyen auxiliaire	Stable	Faible	26-28																												
	Légèrement instable	Modéré	22-25																												
	Instable	Important	18-21																												
	Très instable	Très important	<18																												
Avec moyen auxiliaire	Stable	Modéré	22-23																												
	Instable	Important	<21																												
	Très instable	Très important	<18																												
Malvoyance	- Acuité visuelle - Port de lunettes (vue, lecture)	- test de l’acuité visuelle																													
Troubles auditifs	- Port d’appareils auditifs	- test voix parlée / voix chuchotée à 30 et 60cm de chaque oreille																													

SYNDROMES GERIATRIQUES – HOPITAL DE LAVAUX

Incontinence urinaire	- Utilisation de protections - Dysurie, pollakiurie	- exclure la présence d'un globe, fécalome, prolapsus - TR : tonus sphinctérien, taille de la prostate Etiologies possibles d'une incontinence urinaire : - chronique : SURF : stress (effort), urgence, regorgement, fonctionnel - aiguë : DRIP : délirium, rétention, infection, pharma		DIAPERS : delirium / démence / diabète, infection / inflammation, atrophie des tissus vaginaux, pharma / psychologique , excès d'output urinaire, restriction de la mobilisation, selles impactées (fécalome) / atteinte des nerfs sacrés
Dénutrition	- NRS / Kondrup - Port de prothèse dentaire - Mesure du poids	Péjoration de l'état nutritionnel	Gravité de la maladie	
		Pas de péjoration : 0 point	Pas de stress : 0 point	
		Degré 1 (léger) : 1 point - perte de poids >5% en 3 mois ou - a mangé un peu moins durant dernière semaine	Degré 1 (léger) : 1 point - fracture de la hanche - maladies chroniques avec complications aiguës (cirrhose, BPCO, dialyse, diabète, ...)	
		Degré 2 (modéré) : 2 points - perte de poids >5% en 2 mois ou - a mangé moins de la moitié de sa ration durant dernière semaine - BMI entre 18.5 et 20.5	Degré 2 (modéré) : 2 points - opérations importantes de l'abdomen - AVC - pneumonies sévères	
		Degré 3 (sévère) : 3 points - perte de poids >5% en 1 mois ou - n'a pratiquement rien mangé durant dernière semaine - BMI < 18.5	Degré 3 (sévère) : 3 points - TCC, polytrauma - brûlures graves - allogreffe - soins intensifs	
		Age du patient : si > 70 ans : 1 point		→ avis diététique si NRS > 3/7
Ostéoporose	- Mesure de la taille - Signe du sapin - Distance mur-occiput - Distance côtes-bassin	- Suspicion d'ostéoporose si perte de taille ≥ 4cm F et ≥ 6 cm H - Suspicion d'ostéoporose si distance mur-occiput > 0 cm - Suspicion d'ostéoporose si distance > 2 travers de doigts (mains de l'examineur sur ligne axillaire médiane, index en contact sous les dernières côtes palpables, estimation de la distance de la partie inférieure des côtes et le bassin)		
Dépendance fonctionnelle	- Dépendance aux AVQs et/ou AIVQs	6 AVQs	7 AIVQs	
		Manger	Téléphone	
		Se laver	Faire les courses	
		S'habiller	Préparer le repas	
		Utilisation des WC	Faire le ménage	
		Marcher	Faire la lessive	
		Transferts	Gestion des finances	
			Utilisation des transports publics	

Ref : « Comment dépister les syndromes gériatriques au cabinet ? » Rev Med Suisse 2009 ; 5 : 2205-10, Dre Monod. « Chutes et personnes âgées » PrimaryCare 2006;6: Nr. 11, Dr Büla. « Evaluation gériatrique globale », Guide de poche, deuxième édition, Editions Médecine & Hygiène, Dr Félix.